

ALESANDRO JOSE DE MORAIS

MEDICAMENTOS:	Tem tontura ao deitar do lado (E).
SINTOMAS/QUEIXAS	HAB / DM / colesterol / cansaço
BANHEIRO	1x
HORA QUE ACORDA	21:30
HORA QUE DORME	5:30
PRATICA EXERCICIO	não

IAH = 68.3

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE: sim ALMOÇO: sim LANCHE: sim JANTA: sim -> 19hr

2 / 11 P: automático
22 Mase.

06/03 P= 7.0 med. - 9.8 efv
23 IAH = 5. efv (1x q IAH auto). / Central 3,9
m. de uso: 10.8.
Biologix.

12/06 P= 7.0 cmH₂O Bem adaptado / não tódo
2023 IAH = 1,4 melhor da rondância
m. de uso = 7h13' min

03/05 P= 7cmH₂O - Relata melhora da tontura
24 IAH = 1.8 efv - Caminhada de 4 à 5x.
m. de uso: 7h30'

02/01 P= 7.0 cmH₂O Bem adapt., s/ quei-
25 IAH = 1.6 efv xas.
m. de uso: 1.6 efm
fuga = 1.6 efm
Tubo filtro e fixador. Jua.



RESULTADOS

O estudo polissonográfico revela eficiência do sono reduzida (76.4 %). A latência do sono foi reduzida (1.7 min) e a latência do estágio REM normal (116.7 min). Distribuição dos estágios do sono mostra aumento de estágio N1, redução de sono REM e ausência de estágio N3. Foram observadas 253 trocas de estágio.

Foram registradas 332 apneias obstrutivas, 13 centrais, 2 mistas e 71 hipopneias, com índice de 68.3 apneia-hipopneias por hora; foram registrados 357 despertares (58.4 micr/hora), sendo 337 relacionados a evento respiratório. A saturação da oxi-hemoglobina atingiu valor mínimo de 81%. Presença de roncos de intensidade moderada.

CONCLUSÃO

- 1) Eficiência do sono reduzida. Dificuldade para manter o sono, com aumento da frequência de despertares longos.
- 2) Arquitetura do sono mostra aumento de estágio N1, redução de sono REM e ausência de estágio N3.
- 3) Síndrome do ronco.
- 4) Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono de grau acentuado – IAH = 68.3 /h.

Dr. César Osório de Oliveira
CRM 60.748
Medicina do Sono/Neurologia

Dr. Edilson Zandanelia
CRM 61.454
Medicina do Sono/Otorrinolaringologia